

Operationeel Samenwerkingsprotocol: Digitale Netwerkgroep en Multidisciplinaire Samenwerking

1. Strategische Context: De Zorgkloof richting 2040

De Nederlandse gezondheidszorg nadert een demografisch breekpunt. In 2040 zal de 'dubbele vergrijzing' haar piek bereiken met circa 4,7 miljoen 65-plussers, wat neerkomt op ruim een kwart van de totale bevolking. Indien we vasthouden aan ons huidige zorgmodel, zal de vraag naar complexe ondersteuning resulteren in een noodzakelijk personeelsvolume van 2 miljoen zorgverleners — een beslag op de nationale arbeidsmarkt dat macro-economisch onhoudbaar is. We moeten daarom nu handelen om de transitie van 'zorgen voor' naar 'samen zorgen dat' te realiseren. De urgentie wordt onderbouwd door de volgende kerncijfers:

- **Huidig tekort (2022):** 80.000 zorgmedewerkers, waarvan 60.000 specifiek binnen de VVT-sector.
- **Demografische druk 2040:** 4,7 miljoen ouderen met een verdubbeling van de complexe zorgvraag.
- **Onhaalbaar arbeidsbeslag:** Noodzaak van 2 miljoen zorgverleners bij ongewijzigd beleid.
- **Economische druk:** Zorguitgaven groeien momenteel tweemaal sneller dan de rest van de nationale economie, wat andere vitale sectoren verdringt. Dit protocol is het fundament voor een toekomstbestendige werkwijze waarbij professionele inzet wordt gereserveerd voor waar het strikt noodzakelijk is, door maximaal te faciliteren op zelfredzaamheid en netwerkgroep.

2. Methodische Kaders voor Gelijkwaardig Partnerschap

Om de samenwerking tussen professionals, cliënten en mantelzorgers te objectiveren, hanteren we gestructureerde methodieken. Deze modellen zijn geen optionele extra's, maar strategische instrumenten om het 'arbeidsbeslag' te reduceren door taken te verschuiven van de professional naar het informele netwerk.

- **Het 5A-model (Zelfmanagementondersteuning):** De professional doorloopt de stappen **Achterhalen** (behoeften), **Adviseren** (opties), **Afspreken** (doelen), **Assisteren** (barrières slechten) en **Arrangeren** (vervolgzorg in netwerk). Dit dwingt tot een faciliterende in plaats van een overnemende rol.
- **Het SOFA-model (Samenwerking Mantelzorg):** We erkennen de mantelzorger in vier rollen: als **Partner** in de zorg, als **Hulpvrager** (ondersteuningsbehoefte), als **Persoonlijke relatie** van de cliënt en als **Expert** (unieke kennis). Het bewust schakelen tussen deze rollen voorkomt ruis en overbelasting.
- **Het WIFA-model (Vrijwilligersinzet):** Voor duurzame integratie van vrijwilligers moeten we hen structureel **Waarderen**, tijdig **Informeren**, adequaat **Faciliteren** (scholing) en werkzaamheden scherp **Afstemmen** met formele zorg om overlap te elimineren. Door deze kaders methodisch toe te passen, transformeren we de werkvloer naar een ecosysteem waar de professional de regie voert over de netwerkcapaciteit, ondersteund door digitale instrumenten.

3. Digitale Communicatieplatformen: Functionaliteit en Selectie

Technologie is de hefboom voor netwerkzorg. De keuze voor een platform is een strategische beslissing die bepaalt hoe efficiënt het zorgecosysteem communiceert. | Kenmerk | Familienet | CarenZorgt (Caren) | OZOverbindzorg (OZO) || ----- | ----- | ----- | ----- || **Primaire Doelstelling** | Sfeer, welzijn en informele verbinding. | Transparantie via dossierinzage (Nedap-koppeling). | Multidisciplinaire netwerkregie en afstemming. || **Type Systeem** | Intra-organisatorisch (sociaal). | Intra-organisatorisch (dossier). | **Inter-organisatorisch** (netwerk). || **Functionaliteit** | 'Meehelp-oproep', Levensboek, foto-app. | ECD-inzage, dagrapportages, berichten. | Taakbeheer, signaalafgifte, ketencommunicatie. || **Grootste Nadeel** | Beperkt tot informele uitwisseling. | **Geen mobiele app/push-notificaties.** | Vereist actieve regie van alle partners. || **Maatschappelijke Impact** | Verhoogt informele participatie; geeft rust. | Direct inzicht in formele zorgverlening. | **€ 273 mln besparing/jaar** door preventie. |

Strategische Differentiatie:

- **Familienet** is optimaal voor intramurale settings om de drempel voor familieparticipatie te verlagen.
- **CarenZorgt** biedt transparantie binnen één organisatie, maar de afwezigheid van een app en push-notificaties (Stichting Omega, 2025) kan de responsrespons vertragen.
- **OZOverbindzorg** is het aangewezen instrument voor complexe, domeinoverstijgende situaties. Waar Caren beperkt is tot de eigen organisatie, verbindt OZO gemiddeld 24 actoren (huisarts, apotheek, wijkteam), wat essentieel is om crisisopnames te voorkomen. Eenduidigheid in platformgebruik bespaart minuten per cliënt, die in 2040 essentieel zijn om de zorg toegankelijk te houden.

4. Operationele Etiquette en Spelregels voor Digitale Communicatie

Strikte etiquette beschermt de professionele autonomie en voorkomt dat digitale communicatie een extra belasting wordt.

- **Responstijden:** De '48-uurs regel' is de standaard voor niet-dringende berichten. Digitale platformen zijn geen kanalen voor acute medische vragen; hiervoor blijft de telefonische route verplicht.
- **Regie en Contact:** Om informatiefragmentatie te voorkomen, verloopt communicatie uitsluitend via de **eerste contactpersoon** of wettelijk vertegenwoordiger.
- **Inhoudelijke Afbakening:** Platformen zoals Caren of OZO zijn bedoeld voor informatiedeling, niet voor discussies, klachten of uitingen van ongenoegen. Deze horen thuis in een persoonlijk gesprek met de verantwoordelijk manager.
- **Berichtbeheer:** Maak voor nieuwe onderwerpen altijd een **nieuw bericht** aan. Reageren op oude threads vergroot het risico dat updates in de workflow over het hoofd worden gezien. Gedisciplineerd gebruik van deze kanalen is een randvoorwaarde voor de veiligheid van zowel de cliënt als de zorgprofessional.

5. Klinische Registratie en de RIZA-methodiek

Uniforme registratie van behandelwensen is cruciaal voor de continuïteit, vooral buiten kantooruren. Dit voorkomt ongewenste behandelingen en onnodige druk op de spoedzorg. **De RIZA-methode (ICPC-code A20):** Behandelwensen worden vastgelegd volgens de systematiek: **R** eanimatie, **I** C-behandeling, **Z** iekenhuisopname, **A** ntibiotica.

1. **Format in het HIS:** Registreer de uitkomsten als een compacte regel in de episoderegel van ICPC A20. Gebruik + (wel), - (niet) of ? (onbekend/niet besproken). Voorbeeld: R+I-Z?A+.
2. **Eindverantwoordelijkheid:** Hoewel de POH of verpleegkundige het gesprek voert, is de **huisarts (GP)** wettelijk de **eindverantwoordelijke** voor de definitieve autorisatie en registratie in het HIS.
3. **Processtappen:**
4. Voer het behandelwensgesprek (bij voorkeur met mantelzorger).
5. Maak episode A20 aan en noteer uitsluitend de RIZA-status in de episoderegel.
6. Controleer de **LSP-toestemming** voor gegevensuitwisseling met de huisartsenpost.
7. Actualiseer de RIZA-status jaarlijks of bij klinische wijziging. Elke correcte registratie bespaart kostbare tijd bij een acute overdracht en waarborgt de waardigheid van de cliënt.

6. Juridische Kaders, Privacy en Arbo-preventie

Veilige netwerkzorg vereist juridische kaders die de inzet van alle partners beschermen zonder professionals onnodig te belasten.

1. **Wet BIG en Aansprakelijkheid:** Mantelzorgers handelen niet beroepsmatig en mogen voorbehouden handelingen (zoals injecteren) uitvoeren mits zij bekwaam zijn en de cliënt instemt. De organisatie heeft een toezichthoudende rol: bekwaamheid moet worden geverifieerd en vastgelegd.
2. **Privacy:** Cliëntautonomie staat centraal. De cliënt beheert de 'vertrouwensgroep' en de bijbehorende activatiecodes. Toegang moet beperkt blijven tot direct betrokkenen.
3. **Arbovisie 2040 en PSA:** Om uitval door psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen, zijn organisaties conform de Arbowet verplicht tot:
4. Digitale registratie van de **RI&E**.
5. Het afsluiten en digitaal registreren van een **Basiscontract met de arbodienst**.
6. **Draagkracht Mantelzorg:** Gebruik de **Caregiver Strain Index (CSI)**. Bij een score van 7 of hoger is er sprake van overbelasting; zet direct in op respijtzorg (logeerzorg) om uitval in het netwerk te voorkomen. Toekomstbestendige zorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Door methodische samenwerking en gedisciplineerde inzet van technologie bouwen we aan een zorgstelsel dat ook in 2040 menswaardig en toegankelijk blijft.